

Introducción al Ojo Rojo

El **ojo rojo** es un motivo de consulta muy frecuente en oftalmología y en general, su diagnóstico suele ser absolutamente clínico. Es importante conocer la lista de patologías en cada grupo para enfrentarlas, reconocerlas y manejarlas adecuadamente.

Se clasifica clásicamente en dos grandes grupos:

- **Ojo rojo periférico o superficial**
- **Ojo rojo profundo o periquerático** (alrededor de la córnea)

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: - En el ojo rojo superficial, la congestión vascular predomina hacia los fondos de saco (alejada de la córnea). - En el ojo rojo profundo, los vasos sanguíneos están dilatados y convergen hacia el borde de la misma córnea (periquerático o central).

Causas de Ojo Rojo

A continuación, se dividen estructuralmente las causas principales.

1. Ojo Rojo Superficial o Periférico

Suelen ser condiciones inflamatorias o infecciosas más leves. - Todas las **conjuntivitis** (bacteriana, viral, alérgica). - **Patología de párpado: Blefaritis, Orzuelo, y Chalazión.** - **Inflamación del saco lagrimal: Dacriocistitis.** - **Infección periorbitaria: Celulitis Preseptal.**

2. Ojo Rojo Profundo o Periquerático

Suelen ser patologías habitualmente mucho más graves que requieren atención especializada rápida. - **Patología de la córnea en sí: Queratitis y erosión corneal.** - **Uveítis.** - **Glaucoma Agudo** (condición muy grave que requiere atención inmediata). - **Endoftalmitis** (la infección más grave de los ojos). - **Escleritis y Epiescleritis.** - **Celulitis Orbitaria.**

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Es imprescindible saber diferenciar clínicamente una **celulitis preorbitaria o preseptal** (frecuentemente superficial) de una **celulitis orbitaria** (profunda y muy grave), dado el riesgo altísimo de compromiso visual y sistémico de esta última.

Signos de Alarma en Patología Ocular

La presencia de cualquiera de los siguientes signos siempre sugiere una patología ocular grave y es un **signo de alarma**:

- **Baja en la agudeza visual:** que los ojos no estén viendo bien siempre es un signo de alarma en todo tipo de patología.
- **Blefaroespasmos:** cierre del ojo de manera muy intensa con dificultad para abrirlo.
- **Fotofobia:** molestia acusada o ardor con la luz. (Tanto la fotofobia como el blefaroespasmos sugieren firmemente patología de la córnea).
- **Sensación de cuerpo extraño:** cuando es muy intensa también sugiere patología corneal.

- **Dolor muy intenso:** clásico en **Endoftalmitis**, patología de córnea, y **Glaucoma Agudo**.
- **Hipopion:** presencia de pus en la cámara anterior (clásico en **Uveítis** y **Endoftalmitis**).
- **Afectación de la pupila:**
 - - Miosis: frecuente en **Uveítis**.
 - - Midriasis fija: característico del **Glaucoma Agudo**.
 - - *Nota:* La patología de córnea por sí sola en general **no afecta a la pupila**.

TABLA 5.1.1: HALLAZGO CLÍNICO VS PATOLOGÍA SOSPECHOSA SUGERIDA	
HALLAZGO CLÍNICO	PATOLOGÍA SOSPECHOSA SUGERIDA
Fotofobia + Blefaroespasmos	Patología de córnea
Miosis pupilar + Hipopion	Uveítis (o Endoftalmitis si es muy grave)
Midriasis fija + Dolor intenso	Glaucoma Agudo

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Las conjuntivitis clásicas **nunca** deberían cursar con baja aguda de agudeza visual, dolor intenso, ni alteración pupilar. Si uno de estos síntomas está presente, asuma un "Ojo Rojo Profundo" hasta que se demuestre lo contrario.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Un paciente de treinta años consulta por ojo rojo izquierdo de dos días de evolución. Al examen presenta enrojecimiento difuso, secreción purulenta abundante y sensación de arenilla. La agudeza visual es normal, no hay fotofobia ni dolor. ¿Cuál es la clasificación más adecuada de este cuadro?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para ojo rojo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El ojo rojo se clasifica en superficial y profundo o periquerático, orientando el enfrentamiento diagnóstico inicial.
- El ojo rojo superficial corresponde principalmente a conjuntivitis: enrojecimiento difuso, secreción, sin compromiso visual.
- El ojo rojo profundo o periquerático compromete estructuras internas: enrojecimiento periquerático y dolor ocular real.
- Los cinco signos de alarma que obligan a derivación urgente son: disminución de agudeza visual, blefaroespasmos, fotofobia, hipopión y midriasis fija.
- Ante cualquier signo de alarma, la conducta del médico general es derivar de urgencia al oftalmólogo sin intentar manejo.
- La distinción entre ojo rojo superficial y profundo es fundamental para no subestimar patologías que amenazan la visión.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (OJO ROJO)

PREGUNTA 1

Un paciente de treinta años consulta por ojo rojo izquierdo de dos días de evolución. Al examen presenta enrojecimiento difuso, secreción purulenta abundante y sensación de arenilla. La agudeza visual es normal, no hay fotofobia ni dolor. ¿Cuál es la clasificación más adecuada de este cuadro?

- A) Ojo rojo profundo con signos de alarma
- B) Ojo rojo superficial sin signos de alarma
- C) Uveítis anterior aguda
- D) Glaucoma agudo de ángulo cerrado
- E) Queratitis bacteriana

PREGUNTA 2

Una mujer de cuarenta y cinco años consulta por ojo rojo derecho con dolor intenso, visión borrosa, fotofobia y vómitos de doce horas de evolución. Al examen usted nota enrojecimiento periquerático y midriasis fija que no reactiva a la luz. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Indicar antihistamínicos tópicos y control en una semana
- B) Prescribir antibióticos tópicos y citar en tres días
- C) Derivar de urgencia al oftalmólogo
- D) Administrar corticoides tópicos y observar
- E) Solicitar cultivo de secreción conjuntival y esperar resultado

PREGUNTA 3

Un médico general revisa los signos de alarma del ojo rojo para identificar casos que requieren derivación urgente. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico del ojo rojo superficial y NO corresponde a un signo de alarma?

- A) Disminución de la agudeza visual
- B) Hipopión
- C) Secreción conjuntival purulenta abundante
- D) Midriasis fija
- E) Blefarospasmo

RESUMEN: OJO ROJO

El ojo rojo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica del médico general. En esta clase introductoria se establece la clasificación fundamental que permite organizar el enfrentamiento diagnóstico: ojo rojo superficial versus ojo rojo profundo o periquerático. El ojo rojo superficial corresponde principalmente a las conjuntivitis, condición muy frecuente y de manejo más accesible para el médico general. El ojo rojo profundo o periquerático en cambio corresponde a patologías más graves que comprometen estructuras internas del ojo, como la córnea, el iris, el cuerpo ciliar o la cámara anterior. La distinción clínica entre ambos tipos es fundamental para no subestimar cuadros que pueden amenazar la visión. En el ojo rojo superficial la hiperemia es difusa, hay secreción, picazón, y generalmente no hay dolor significativo ni compromiso visual. En el ojo rojo profundo el enrojecimiento es periquerático, es decir, más marcado alrededor de la córnea formando un anillo rojizo en esa zona, y se acompaña de dolor ocular real y potencial compromiso visual. Lo más importante que el médico general debe dominar son los signos de alarma que indican derivación urgente al oftalmólogo. Estos cinco signos de alarma son: disminución de la agudeza visual, blefarospasmo, fotofobia, presencia de hipopión, y midriasis fija. Ante cualquiera de ellos, la conducta es derivación urgente. La presencia de dolor ocular verdadero también orienta hacia patología más grave. Esta clasificación inicial y el reconocimiento de los signos de alarma son la clave para el enfrentamiento correcto del ojo rojo.